

DIARREA AGUDA

Jaime Madroñal Menéndez, Patricia Díaz Gutiérrez, Einstein Domingo León Méndez, Ulises Oswaldo Cabrera Urbina.

INTRODUCCIÓN

Diarrea se define como aumento del número de deposiciones (más de 3 deposiciones al día) o disminución de la consistencia de las heces.

- **Diarrea aguda:** cuando la duración <2 semanas.
- **Diarrea crónica:** cuando la duración es < 4 semanas.
- **Diarrea no invasiva:** con heces acuosas sin productos patológicos y paciente afebril.
- **Diarrea invasiva:** con heces menos abundantes, con moco o sangre y acompañadas frecuentemente de fiebre y dolor hipogástrico.

Clasificación de las diarreas:

- **Diarrea no inflamatoria.**
- **Diarrea inflamatoria.**

Etiología

Diarrea	Inflamatoria	No inflamatoria
Bacterias	• Campylobacter jejuni • Escherichia coli (enterohemorrágica o enteroinvasivo) • Shigella spp • Salmonella spp no Typhi • Vibrio parahaemolyticus • Yersinia enterocolitica • Clostridium difficile • Listeria monocytogenes • Plesiomonas shigelloides • Aeromonas hydrophila • Klebsiella oxytoca • Enterocolitis neutropénica	• Staphylococcus aureus • Bacillus cereus • Clostridium perfringens • E. coli (enterotoxigénico, enteropatógeno o difusamente adherente) • Vibrio cholerae serogrupos O1 y O139 • Plesiomonas shigelloides • Aeromonas hydrophila • Tropheryma whipplei • Diarrea de Brainerd
Virus	• Entamoeba histolytica • Otros	• Rotavirus • Norovirus • Astrovirus
Protozoos y helmintos	• Entamoeba histolytica • Otros	• Giardia lamblia • Otros

- **Infecciosas.** Supone el 90% de las causas:
 - **Bacterias:** Shiguela, Salmonella, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli, Vibrio cholerae (diarrea aguda severa principalmente en países en vías de desarrollo), Clostridium difficile (diarrea nosocomial asociado a la toma reciente de antibióticos: cefalosporina 2 y 3er generación, clindamicina y fluorquinolonas, produce colitis pseudomembranosa).
 - **Virus:** Norovirus (Norwalk), rotavirus, adenovirus, astrovirus, calicivirus, parvovirus, coronavirus.
 - **Parásitos:** Giardia lamblia, Cryptosporidium, Microsporidium, Entamoeba histolytica.
 - **Hongos:** Candida albicans, Histoplasma.
- **Fármacos:** citostáticos, analgésicos, cardiovasculares (digoxina, antiarrítmicos y

antihipertensivos), antimicrobianos (eritromicina, tetraciclinas, tuberculostáticos, aciclovir), antiparkinsonianos, anticonvulsivantes, anestésicos, antidiabéticos orales, otros (sulfasalacina, azatioprina, corticoides, teofilina, anticonceptivos orales).

- **Tumores.** linfoma, adenoma vellosos colónico, tumor carcinoide (VIPOMA).
- **Patologías crónicas.** síndrome de mala absorción, enfermedad inflamatoria intestinal (EII), enfermedad de Whipple, impactación fecal (por rebosamiento)
- **Otros.** metales pesados (plomo, arsénio, cobre, magnesio, zinc), conservantes alimenticios, síndrome de asa ciega, malaria. etc.
- **Disregulaciones iónico-metabólicas:** diabetes mellitus, hipertiroidismo, hiperpotasemia, hipermagnesemia.

DIAGNÓSTICO

Anamnesis

Necesitamos realizar una historia clínica exhaustiva en la que incluyamos, además de lo habitual:

- Consistencia, número de deposiciones y existencia de productos patológicos en heces (sangre, moco o pus). Nocturnidad (suele indicar organicidad).
- Síntomas que acompañan, como fiebre, dolor abdominal, náuseas o vómitos.
- Antecedentes farmacológicos (uso de antibióticos) u hospitalización en los días previos.
- Transgresiones dietéticas, posibilidad de haber ingerido comida en mal estado.
- Viajes al extranjero.
- Convivientes con misma sintomatología.

Exploración física

- Debe valorarse la gravedad del cuadro, prestando atención a las constantes vitales y al nivel de hidratación
- Exploración abdominal (inspección, auscultación, palpación y percusión) que incluya auscultación de la peristalsis, palpación para localizar dolor o posibles masas y descartar signos de irritación peritoneal sugestivos de un abdomen agudo.
- En caso de sospecha, tacto rectal para descartar fecaloma con diarrea por rebosamiento u objetivar sangre, moco o pus en las heces.

Pruebas complementarias

¡ALERTA!

- **Criterios de gravedad:** deshidratación por diarrea profusa acuosa, fiebre elevada, dolor abdominal intenso o irritación peritoneal, sangre en heces, paciente de alto riesgo (inmunosupresión, ancianos frágiles, hospitalizados), defecaciones: > 6 deposiciones/día y más de 1 día de evolución.

Se realizarán analítica sanguínea en diarrea persistente más de 48-72 horas o en presencia de criterios de gravedad.

- Hemograma
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, LDH, amilasa, bilirrubina, PCR.
- Coagulación
- Gasometría venosa (descartar acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato en heces).

- Coprocultivos
- Radiografía simple de abdomen, radiografía de abdomen en bipedestación y de tórax posteroanterior y lateral. Cuando se sospeche abdomen agudo.

¡NO OLVIDAR!

• CRITERIOS DE INGRESO:

- Inestabilidad hemodinámica o síntomas y signos de deshidratación intensa.
- Intolerancia oral pese a antieméticos.
- Factores de riesgo (inmunosupresión, comorbilidades, edad avanzada).
- Sospecha de abdomen agudo
- Alteración importante de pruebas complementarias (deterioro de función renal, alteraciones hidroelectrolíticas, etc)
- Hemorragia intensa asociada.

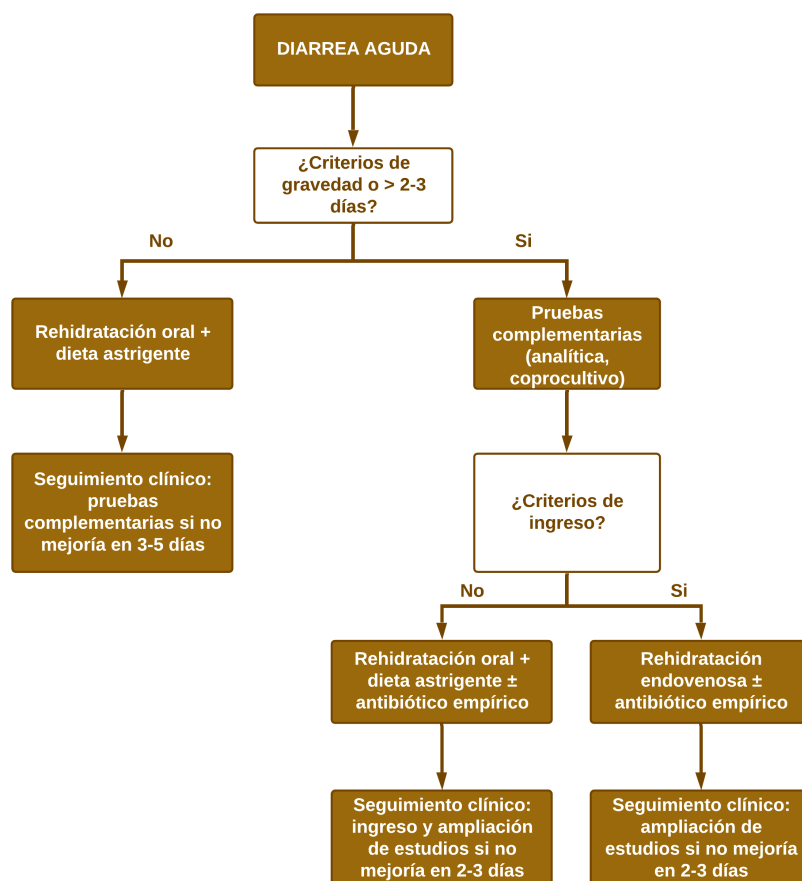
TRATAMIENTO

- **Reposición de líquidos y electrolitos:** vía oral, si se tolera: con 1,5-2 litros diarios de la solución de la OMS. En caso de no tolerar la vía oral, se realizará por vía intravenosa: **suero fisiológico** 2500-3000 ml cada 24h IV y 1mg/kg/día de CLK. (20 mEq de CLK cada 8 horas IV).
- **Dieta astringente:** evitando productos lácteos, grasas o picantes durante 3-4 días y si buena evolución reintroducir paulatinamente dieta habitual.
- **Antibioterapia:** Ciprofloxacino 500-750mg/12h vía oral o 400mg/12h iv durante 3-5 días. Indicado de manera empírica en caso de: diarrea del viajero grave, fiebre >38,5°C, sangre en heces y diarrea moderada-grave en pacientes de riesgo.
- **Analgésicos:** paracetamol 1 gr cada 8h o metamizol 575mg 1 cada 8h.
- **Antieméticos:** metoclopramida 10mg/ml iv. c/ 8 horas, si vómitos incoercibles ondansetrón 4mg 1 cada 8h IV.
- **Antidiarreicos:** Adultos: la dosis inicial es de 4 mg (2 cápsulas) seguida de 2 mg (1 cápsula) tras cada deposición diarreica. La dosis máxima es de 16 mg (8 cápsulas) al día. Niños mayores de 12 años: la dosis inicial de 2 mg (1 cápsula) seguida de 2 mg (1 cápsula) tras cada deposición diarreica; uso controvertido.

Criterios de tratamiento antibiótico

Pacientes con diarrea que presenten.

- Fiebre > 38,5°C
- Malestar general.
- Signos de deshidratación
- Dolor abdominal cólico intenso
- Diarreas con sangre o moco
- Pacientes con inmunodepresión en tratamiento con corticoides, comorbilidad importante o patología vascular.
- Diarrea del viajero de gravedad moderada o grave



BIBLIOGRAFÍA

- López Noguerras MA, Guardiola Arévalo A, Repiso Ortega A. Diarrea aguda. En: Julián Jiménez A. Manual de Protocolos y Actuación en Urgencias. 4ª ed. Toledo: Complejo Hospitalario de Toledo, Hospital Virgen de la Salud; 2014.
- Bujanda Fernández de Piérola L, Barrio Andrés J. Diarrea aguda. En: Ponce J, Castells Garangou A, Gomollón García F. Tratamiento de las enfermedades gastroenterológicas. 3ª ed. Barcelona: Elsevier Doyma; 2011.
- Domínguez García N, Pérez-Jacoiste MA. Diarrea aguda y crónica. En: Aguilar Rodríguez F, Bisbal Pardo O, Gómez Cuervo C, de Largade Sebastian M, Maestro de la Calle G, Pérez-Jacoiste Asin MA et al. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. Hospital 12 de octubre. 7ª ed. Madrid: MSD; 2012.